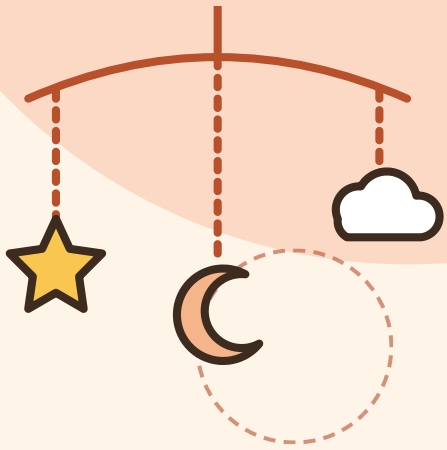
MODULE 1 Pendant la grossesse

La grossesse

« Mon test est positif ! Qu'est-ce que je dois faire ? »

Version de travail du 16/10/2026 · à relire avant la vente



Dans ce module

1.1 Je viens d'apprendre que je suis enceinte, que dois-je faire ?

1.2 C'est quoi tous ces examens ? Ils sont obligatoires ?

1.3 Quand est-ce que je vais le sentir bouger ?

1.4 Mon corps change, est-ce normal ?

1.5 Qu'est-ce qui peut me soulager ?

1.6 Qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'évite ?

1.7 Mon test de diabète est positif

1.8 Je pleure tout le temps, j'ai très faim : c'est normal ?

1.9 Et moi, le futur papa ou coparent, comment l'aider ?

1.10 De quoi ai-je réellement besoin pour accueillir bébé ?

1.11 Comment préparer l'accouchement et le retour à la maison ?

1.12 Quand consulter et fiches à imprimer

Le test est positif : respirez, on avance pas à pas

Joie, surprise, inquiétude… souvent tout à la fois. C'est normal. Un test urinaire positif indique très probablement une grossesse. **Vous n'avez pas besoin de tout organiser aujourd'hui** : quelques étapes simples suffisent pour bien démarrer, et le professionnel qui vous suivra vous aidera à planifier la suite.

1

Prendre rendez-vous

Avec une sage-femme, un médecin généraliste ou un gynécologue. La 1re consultation doit avoir lieu **avant la fin du 3e mois** ; idéalement vers 8 à 10 SA.

2

Faire le point santé

Traitements, compléments, alcool, tabac, alimentation : quelques réflexes à prendre **dès maintenant**, sans culpabiliser pour ce qui s'est passé avant.

3

Déclarer la grossesse

Avant la fin du 3e mois. Le plus souvent, c'est le professionnel qui l'envoie en ligne : elle **ouvre vos droits**.

BON À SAVOIR

SA, semaines de grossesse, mois : comment s'y retrouver ?

Les professionnels comptent en **semaines d'aménorrhée (SA)**, c'est-à-dire depuis le 1er jour de vos dernières règles, et non depuis la conception. On ajoute donc environ 2 semaines aux « semaines de grossesse ». Le terme est fixé à **41 SA** ; la date exacte sera recalculée grâce à la 1re échographie.

1er trimestre	Jusqu'à 14 SA environ (fin du 3e mois)	Consultation, déclaration, 1re écho
2e trimestre	De 15 à 28 SA environ (4e au 6e mois)	Écho morphologique, 100 % dès le 6e mois
3e trimestre	De 29 SA à la naissance (7e au 9e mois)	3e écho, congé maternité, préparation

Et la prise de sang ?

Une prise de sang de **bêta-hCG** n'est pas obligatoire après un test urinaire positif. Le professionnel la prescrira si elle est utile : doute sur les dates, saignements, douleurs, antécédents.

Notez dès aujourd'hui

La date du **1er jour de vos dernières règles** (si vous la connaissez), la durée habituelle de vos cycles, et les symptômes qui vous questionnent. Ces repères aident à dater la grossesse.

Les petits maux du début sont fréquents

Nausées, seins tendus, fatigue intense, envies fréquentes d'uriner, légers tiraillements dans le bas-ventre : ce sont des signes courants du 1er trimestre. Les signes qui doivent faire consulter rapidement sont détaillés page 13.

Vos premières semaines, pas à pas

QUAND	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Cette semaine	Prendre rendez-vous pour la 1re consultation. Commencer l'**acide folique** si ce n'est pas déjà fait. Arrêter l'alcool. Ne rien arrêter ni commencer comme traitement sans avis (appelez votre médecin si vous prenez un traitement régulier).
Avant 10 SA	1re consultation : datation, bilan de santé, prescription des prises de sang et de la 1re échographie. C'est aussi le bon moment pour adopter les précautions alimentaires.
De 11 à 13 SA + 6 j	**1re échographie** : date de début de grossesse et terme, nombre de bébés, mesure de la nuque pour le dépistage de la trisomie 21 (si vous le souhaitez).
Avant la fin du 3e mois	**Déclaration de grossesse** à l'Assurance Maladie et à la CAF/MSA. Vérifier qu'elle a bien été transmise.
Au 1er trimestre	S'inscrire à la **maternité** (tôt dans les grandes villes). Prévoir l'**entretien prénatal précoce**. Réfléchir au moment d'informer votre employeur.
Dès le 4e mois	Consultation chaque mois. Examen bucco-dentaire pris en charge. Penser au mode de garde (voir module 5).

Qui peut suivre votre grossesse ?

Sage-femme	Toute grossesse qui se déroule normalement, de la 1re consultation à l'après-naissance : examens, échographies, préparation, rééducation du périnée. Elle oriente vers un médecin si besoin.
Médecin généraliste	Le début du suivi, souvent jusqu'au 6e ou 7e mois, si la grossesse est sans complication. Il connaît vos antécédents.
Gynécologue-obstétricien	Indispensable si la grossesse est à risque (maladie chronique, jumeaux, antécédents de complication, diabète, hypertension). Possible aussi pour une grossesse normale.
PMI	Centres de Protection maternelle et infantile : consultations et accompagnement gratuits, visites à domicile possibles. Une aide précieuse si vous vous sentez isolée.

Les dernières consultations ont souvent lieu à la maternité où vous accoucherez.

S'inscrire à la maternité

Les maternités sont classées selon les soins qu'elles peuvent donner aux nouveau-nés : **type 1** (grossesses sans risque particulier), **type 2** (avec néonatologie), **type 3** (avec réanimation néonatale, pour les grossesses à haut risque). Une grossesse normale se déroule très bien en type 1. Pensez aussi au **temps de trajet**, à la possibilité de visiter et aux approches proposées (salle nature, accompagnement de l'allaitement…).

Source : ameli.fr · HAS, suivi des femmes enceintes

Le premier rendez-vous : à quoi s'attendre ?

Qu'est-ce qu'on va me demander ? Est-ce que je dois préparer quelque chose ?

Ce rendez-vous, un peu plus long que les autres, sert à **confirmer et dater la grossesse**, faire le point sur votre santé et organiser le suivi. Vous pouvez venir accompagnée.

ON PARLE DE VOUS

Votre santé et votre histoire

- Date des dernières règles, régularité des cycles
- Antécédents médicaux, chirurgicaux, grossesses précédentes
- Allergies, traitements, vaccinations
- Maladies dans la famille (diabète, maladies génétiques…)
- Travail, mode de vie, entourage

ON VOUS EXAMINE

Un examen simple

- Poids, taille, tension artérielle
- Examen clinique selon le contexte (pas toujours gynécologique)
- Frottis si le dépistage du col n'est pas à jour
- Parfois une échographie de datation au cabinet

ON ORGANISE LA SUITE

Ordonnances et calendrier

- Prises de sang et analyse d'urines
- Rendez-vous de la 1re échographie
- Information sur le dépistage de la trisomie 21
- Déclaration de grossesse en ligne
- Acide folique, conseils alimentaires

À APPORTER

Votre petit dossier

- Carte Vitale et carte de mutuelle
- Liste des médicaments et compléments (ou les boîtes)
- Carnet de vaccination ou carnet de santé
- Résultats récents : prises de sang, frottis, groupe sanguin
- Vos questions, notées à l'avance

Vous pouvez parler de tout

Nausées qui vous épuisent, anxiété, grossesse non prévue, difficultés d'argent ou de logement, tensions dans le couple, violences, consommation que vous n'arrivez pas à arrêter : **rien n'est hors sujet**. Le professionnel est tenu au secret et peut vous orienter (PMI, assistante sociale, psychologue, addictologie). En cas de violences : **3919**, gratuit et anonyme.

LE CONSEIL DE PRO

Ouvrez un dossier « grossesse » dès maintenant

Un classeur ou un dossier dans votre téléphone : ordonnances, résultats, comptes rendus d'échographie, dates de rendez-vous. Vous l'emporterez à chaque consultation et à la maternité. Pensez aussi à activer **Mon espace santé**, où certains professionnels déposent vos documents.

Source : ameli.fr, première consultation prénatale

Médicaments, compléments : les bons réflexes

La règle d'or

Ne commencez pas, n'arrêtez pas et ne modifiez pas un traitement **sans avis** d'un médecin, d'une sage-femme ou d'un pharmacien. Traitement au long cours (thyroïde, épilepsie, dépression, asthme…) : **appelez vite** votre prescripteur ; l'arrêter brutalement peut être plus risqué que de le poursuivre.

Les compléments utiles

COMPLÉMENT	POURQUOI	EN PRATIQUE
Acide folique (vitamine B9)	Réduit le risque d'anomalie de fermeture du tube neural (spina bifida).	**0,4 mg par jour**, idéalement dès le projet de grossesse et **jusqu'à 12 SA**. Dose plus forte (souvent 5 mg) si antécédent, traitement antiépileptique ou situation particulière : sur prescription.
Vitamine D	Pour les os de bébé et votre calcium.	En général **une dose unique** prescrite au début du 7e mois.
Fer	Prévenir l'anémie, fréquente en fin de grossesse.	**Uniquement si la prise de sang montre un manque** : le fer en excès n'apporte rien et donne des troubles digestifs.
Iode	Pour la thyroïde et le cerveau de bébé.	**Sel iodé** (sans excès), poisson, produits laitiers. Un complément peut être discuté.
Vitamine B12	Indispensable au développement du système nerveux.	**Supplément indispensable** si vous êtes végétalienne ; à discuter si vous êtes végétarienne.

Contre la douleur ou la fièvre

Le **paracétamol** est le médicament de référence, à la dose la plus faible et le moins longtemps possible. L'**ibuprofène** et les autres anti-inflammatoires (y compris en gel) et l'aspirine à dose antidouleur sont à **éviter pendant toute la grossesse** et **interdits à partir du 6e mois**.

Vérifier un médicament

Le site du **CRAT** (lecrat.fr) fait référence sur médicaments et grossesse ; votre pharmacien peut le consulter avec vous. Un **pictogramme « femme enceinte »** figure sur les boîtes des médicaments à risque. Dites toujours que vous êtes enceinte, y compris chez le dentiste. Plantes et huiles essentielles : **sur avis** aussi.

Alcool, tabac, cannabis : sans jugement, avec de l'aide

Alcool : il n'existe pas de dose sans risque pendant la grossesse ; le plus sûr est zéro, dès maintenant. Si vous avez bu avant de savoir que vous étiez enceinte, ne paniquez pas : arrêtez maintenant et parlez-en, le risque se discute au cas par cas.

Tabac et vapotage : chaque cigarette en moins compte et il n'est jamais trop tard. Les **substituts nicotiniques** sont possibles pendant la grossesse et remboursés ; votre sage-femme peut les prescrire, ainsi qu'à votre partenaire. **Cannabis** : il passe aussi le placenta ; parlez-en pour être accompagnée.

Tabac Info Service 39 89 · **Alcool Info Service 0 980 980 930** · **Drogues Info Service 0 800 23 13 13** — gratuits ou non surtaxés, anonymes.

Sources : HAS · ANSM · CRAT · Santé publique France

Manger pour deux ? Non : manger deux fois mieux

Je dois manger plus ? Et s'il y a des choses que j'ai déjà mangées sans savoir ?

Au 1er trimestre, vos besoins en énergie **n'augmentent presque pas**. Aux 2e et 3e trimestres, ils augmentent un peu : l'équivalent d'une **collation** en plus par jour (un yaourt, un fruit et une tranche de pain, par exemple). Ce qui compte surtout, c'est la **qualité et la variété**. Et si vous avez mangé un aliment « à éviter » avant de le savoir : pas de panique, le risque est faible ; adoptez simplement les précautions à partir d'aujourd'hui.

CHAQUE JOUR

Fruits et légumes

À chaque repas, crus **bien lavés** ou cuits : fibres, vitamines, B9. Au moins 5 portions par jour.

CHAQUE REPAS

Féculents

Pain, pâtes, riz, pommes de terre, de préférence **complets** : énergie durable et moins de constipation.

1 À 2 FOIS PAR JOUR

Protéines

Viande **bien cuite**, œufs **bien cuits**, poisson 2 fois par semaine, légumineuses (lentilles, pois chiches) : fer et protéines.

2 À 3 PAR JOUR

Produits laitiers

Lait pasteurisé, yaourts, fromages autorisés (page 7) : calcium et iode.

À VOLONTÉ

De l'eau

1,5 à 2 litres par jour, plus s'il fait chaud ou si vous vomissez. L'eau du robinet convient.

AVEC MODÉRATION

Sucre, sel, gras

Pâtisseries, boissons sucrées, plats tout prêts : à limiter, sans interdit. Huiles de colza et de noix : intéressantes.

Végétarienne, végétalienne, allergies, religion ?

Une grossesse est possible avec tous les modes d'alimentation, à condition d'en parler : **B12 indispensable** si vous êtes végétalienne, attention au fer, au calcium, à l'iode et aux oméga-3. Une consultation avec une **diététicienne** peut vous être prescrite, de même qu'en cas de jeûne religieux ou de trouble alimentaire, passé ou présent.

EXEMPLE, À ADAPTER À VOS GOÛTS

Une journée dans l'assiette

Petit-déjeuner	Pain complet ou flocons d'avoine, un yaourt ou un verre de lait, un fruit lavé ou une compote.
Déjeuner	Crudités bien lavées, poulet bien cuit, riz ou pâtes, haricots verts, un morceau de comté sans croûte.
Collation	Une poignée d'amandes ou de noix, un fruit, un fromage blanc : utile au 2e et au 3e trimestre.
Dîner	Soupe de légumes, omelette bien cuite ou lentilles, pain, un dessert lacté.

Sources : ANSES · Santé publique France (1000 premiers jours)

Ce que j'évite, et pourquoi

Trois infections transmises par l'alimentation sont bénignes pour l'adulte mais peuvent être graves pour bébé. Quelques gestes simples suffisent à s'en protéger.

INFECTION	À ÉVITER	LES BONS GESTES
Toxoplasmose si vous n'êtes pas immunisée (la prise de sang le dira)	Viande crue, saignante ou rosée (y compris tartare, carpaccio, gibier) ; charcuteries crues, fumées ou séchées (jambon cru, saucisson) ; lait de chèvre cru ; fruits, légumes et herbes mal lavés.	Viande **bien cuite à cœur**. Laver fruits, légumes et aromates, même « bio » ou en sachet. Laver mains, planches et couteaux après la viande crue. Gants pour jardiner ; litière du chat changée par quelqu'un d'autre (ou avec des gants). Prise de sang **chaque mois**.
Listériose pour toutes	Fromages au lait cru et croûte de tous les fromages ; fromages râpés en sachet ; rillettes, pâtés, foie gras, produits en gelée, charcuterie à la coupe ; poisson fumé, cru (sushis), tarama, surimi ; coquillages crus ; graines germées crues.	La bactérie se développe **même au réfrigérateur** : préférer les produits préemballés, respecter les dates, consommer vite après ouverture. Réchauffer les restes jusqu'à ce qu'ils soient **très chauds**. Les aliments cuits (pizza, gratin, quiche) sont sans risque.
Salmonellose pour toutes	Œufs crus ou peu cuits : mayonnaise, mousse au chocolat, tiramisu et pâtisseries crues faits maison, œufs à la coque ou mollets ; volaille insuffisamment cuite.	Œufs cuits jusqu'à ce que le blanc et le jaune soient **fermes**. Mayonnaise et desserts industriels (fabriqués avec des œufs pasteurisés) : possibles.

FROMAGES : OUI

- Pâtes pressées cuites, même au lait cru : **comté, emmental, beaufort, gruyère**, sans la croûte
- Fromages au **lait pasteurisé**, sans la croûte
- Fromages fondus, en portions, à tartiner
- **Tout fromage cuit** : raclette, gratin, pizza, croque
- Yaourts, fromage blanc, petits-suisses

FROMAGES : NON

- Tous les autres fromages **au lait cru** (camembert, brie, reblochon, roquefort, chèvre frais au lait cru…), sauf s'ils sont cuits
- La **croûte** de tous les fromages
- Les fromages **râpés vendus en sachet** (à utiliser seulement en cuisson)
- Le fromage à la coupe resté longtemps à l'air libre

Dans la cuisine et le réfrigérateur

- Réfrigérateur à **4 °C** maximum, nettoyé (avec de l'eau javellisée) deux fois par mois.
- Aliments crus et cuits dans des boîtes séparées.
- Se laver les mains avant de cuisiner et après avoir manipulé de la viande, des œufs ou de la terre.
- Restes : couverts, au frais, consommés rapidement.

Fièvre pendant la grossesse ?

Une fièvre à **38 °C ou plus**, même avec de simples courbatures ou des troubles digestifs, doit faire **consulter rapidement** : c'est parfois le seul signe d'une listériose, qui se soigne bien par antibiotiques si elle est prise tôt.

Sources : ANSES · Santé publique France · ameli.fr

Poisson, café, tisanes : les questions qu'on se pose

Le poisson : oui, deux fois par semaine

Il apporte des **oméga-3, de l'iode et de la vitamine D**, utiles au cerveau et aux yeux de bébé. Mangez-en 2 fois par semaine, **bien cuit**, dont un poisson gras (sardine, maquereau, hareng, saumon). Varier les espèces et les lieux de pêche limite les polluants.

À ÉVITER (MERCURE)

Espadon, marlin, siki, requin, lamproie.

À LIMITER (150 G PAR SEMAINE)

Thon, lotte, bar, bonite, empereur, flétan, dorade, raie, sabre, brochet.

Café, thé, cola : combien ?

Repère : **200 mg de caféine par jour** au maximum.

Expresso	60 à 90 mg
Café filtre (mug)	100 à 140 mg
Thé (tasse)	30 à 50 mg
Cola (canette)	30 à 40 mg
Boisson énergisante	80 mg et plus : **à éviter**

Soit environ 2 cafés par jour, en comptant le thé, le cola et le chocolat.

Tisanes, réglisse, soja

- Tisanes classiques (tilleul, verveine, camomille) : avec modération.
- Tisanes « médicinales », plantes en gélules, huiles essentielles : **seulement sur avis**.
- **Réglisse** (bonbons, boissons anisées, certaines tisanes) : à éviter en quantité, elle peut faire monter la tension.
- **Soja** (boissons, desserts, tofu) : pas plus d'un produit par jour.
- Algues et compléments à base d'algues : prudence (excès d'iode).

SI VOUS AVEZ DÉJÀ UN JEUNE ENFANT

Le cytomégalovirus (CMV) : des gestes d'hygiène simples

Ce virus très courant, souvent sans symptôme, circule beaucoup chez les enfants de moins de 3 ans (salive, urines). Contracté pendant la grossesse, il peut avoir des conséquences pour bébé. Sans vous priver des câlins :

- lavez-vous les mains après chaque change, mouchage ou repas de votre enfant ;
- ne partagez pas sa cuillère, son verre ou sa brosse à dents, et ne terminez pas son assiette ;
- évitez de mettre sa tétine dans votre bouche ; embrassez-le plutôt sur le front ou les joues.

Ces gestes valent aussi si vous travaillez avec de jeunes enfants (crèche, école, assistante maternelle) : parlez-en à la médecine du travail.

Sources : ANSES · EFSA · HCSP (CMV)

Nausées, poids, digestion : les petits tracas du début

Je n'arrive rien à avaler le matin : est-ce que bébé manque de quelque chose ?

Rassurez-vous : au 1er trimestre, bébé puise ce dont il a besoin dans vos réserves. Les nausées touchent plus d'une femme enceinte sur deux et s'atténuent le plus souvent vers **12 à 16 SA**. L'objectif est de manger ce qui passe, sans culpabiliser.

La prise de poids : des repères, pas un objectif

IMC avant grossesse	Prise de poids repère
Moins de 18,5	12,5 à 18 kg
18,5 à 24,9	11,5 à 16 kg
25 à 29,9	7 à 11,5 kg
30 et plus	5 à 9 kg

Jumeaux : davantage. Pas de régime pendant la grossesse ; le professionnel suit votre courbe.

Les nausées du début

- Petits repas fréquents ; ne restez pas l'estomac vide.
- Quelque chose de sec (biscotte) avant de vous lever.
- Boire par petites gorgées, plutôt entre les repas.
- Aliments froids, peu odorants ; éviter les plats gras.
- Le gingembre peut aider certaines femmes.

Consultez si vous ne gardez rien (ni eau ni aliments) pendant 24 h, si vous perdez du poids ou urinez peu : c'est soignable.

Constipation

Très fréquente (les hormones ralentissent l'intestin, le fer aggrave). Buvez régulièrement, misez sur les **fibres** (légumes, fruits, pruneaux, céréales complètes, légumineuses) et bougez chaque jour. Pas de laxatif sans avis.

Brûlures d'estomac

Plus fréquentes en fin de grossesse. Fractionnez les repas, évitez les plats très gras, épicés ou acides le soir, ne vous allongez pas juste après manger. Votre pharmacien peut vous conseiller un traitement adapté à la grossesse.

L'ESPACE DU KINÉ

Bouger après le repas : un petit geste qui aide

10 à 15 minutes de marche après le déjeuner ou le dîner facilitent la digestion, limitent les remontées acides et aident à réguler le sucre dans le sang. En cas de brûlures d'estomac, évitez de vous allonger juste après manger et surélevez légèrement la tête du lit.

Sources : ANSES · HAS · CNGOF

Travail, sport, trajets : faut-il tout changer ?

Non : la plupart des activités peuvent continuer. Mais certaines situations méritent d'être signalées tôt au professionnel qui vous suit, et parfois à la médecine du travail.

Au travail : vos protections

- Vous **n'êtes pas obligée** d'annoncer votre grossesse tout de suite, ni de donner une raison à l'embauche.
- Une fois l'employeur informé (idéalement par écrit, avec un certificat), vous êtes **protégée contre le licenciement**.
- **Absences autorisées et payées** pour les examens médicaux obligatoires ; le second parent salarié peut accompagner jusqu'à 3 de ces examens.
- Travail de nuit : vous pouvez demander un **poste de jour**.

Ce qu'il faut signaler

- Produits chimiques, solvants, pesticides, plomb, rayonnements.
- Port de charges lourdes, station debout prolongée, longs trajets.
- Contact avec de jeunes enfants ou des malades (infections).
- Horaires de nuit, stress important.

La **médecine du travail** peut demander un aménagement de poste. Indépendante, demandeuse d'emploi, étudiante, fonctionnaire : les règles diffèrent, renseignez-vous selon votre statut.

L'ESPACE DU KINÉ

Bouger pendant la grossesse : oui, et c'est bénéfique

Sauf contre-indication médicale, l'activité physique réduit le mal de dos, la fatigue, le risque de diabète gestationnel et prépare le corps à l'accouchement. Repère : **150 minutes par semaine** d'activité modérée (vous pouvez parler en bougeant), par exemple 30 minutes, 5 jours sur 7.

- **À privilégier** : marche, natation, aquagym, vélo d'appartement, yoga ou Pilates prénatal, renforcement doux.
- **À éviter** : sports de contact et de combat, sports à risque de chute (ski, équitation, escalade), plongée sous-marine, efforts en altitude non habituels.
- Si vous étiez sportive, vous pouvez continuer en **réduisant l'intensité** ; parlez-en au professionnel qui vous suit.
- Pensez au **périnée** dès maintenant : expirer en contractant le périnée avant de soulever une charge, éviter de pousser aux toilettes.

En voiture

La ceinture reste **obligatoire** : la sangle du bas **sous le ventre**, sur les hanches, celle du haut entre les seins. Faites une pause toutes les 2 heures pour marcher et boire.

Voyages, bains, saunas

Avion : en général possible ; vérifiez la destination (zika, paludisme) et les règles de la compagnie. Bains chauds, sauna, hammam et jacuzzi : **à éviter** au 1er trimestre (élévation de la température).

Sources : HAS, activité physique et grossesse · service-public.fr

Le suivi de grossesse : les grands repères

En France, le suivi comprend **7 consultations prénatales** (une au 1er trimestre, puis une par mois à partir du 4e mois) et **3 échographies**. Il peut être renforcé si besoin ; le détail est repris dans le chapitre 1.2.

QUAND	EXAMEN	À QUOI IL SERT
Avant 15 SA	1re consultation et bilan sanguin	Dater la grossesse, groupe sanguin, immunités, dépistages, déclaration
11 à 13 SA + 6 j	1re échographie	Terme, nombre de bébés, nuque (dépistage de la trisomie 21, proposé)
Dès le 4e mois	Consultation prénatale mensuelle	Tension, poids, urines, croissance du ventre, cœur de bébé
20 à 25 SA	2e échographie, « morphologique »	Anatomie de bébé organe par organe, placenta
24 à 28 SA	Dépistage du diabète gestationnel	Si facteurs de risque (âge, poids, antécédents)
30 à 35 SA	3e échographie	Croissance, position de bébé, placenta
8e-9e mois	Consultation d'anesthésie	Obligatoire, même sans péridurale prévue
34 à 38 SA	Prélèvement vaginal	Recherche du streptocoque B

Le bilan sanguin du début

- **Groupe sanguin, rhésus** et recherche d'anticorps (RAI). Rhésus négatif : un test sur votre sang peut indiquer le rhésus de bébé, et une injection préventive est proposée si besoin.
- **Toxoplasmose, rubéole, syphilis, hépatite B**.
- **VIH, hépatite C** : proposés systématiquement.
- Glycémie à jeun si facteurs de risque ; analyse d'urines.

Dépistage ne veut pas dire diagnostic

Le dépistage de la trisomie 21 est **proposé, jamais imposé**. Il donne un niveau de risque, pas une certitude. Si le risque est élevé, un test ADN sur prise de sang puis, si besoin, un prélèvement (amniocentèse) peuvent être proposés. Prenez le temps de poser vos questions avant chaque étape : vous pouvez aussi choisir de ne pas faire le dépistage.

Les vaccins recommandés pendant la grossesse

Grippe et **Covid-19** : pendant la saison, à n'importe quel trimestre. **Coqueluche** : à chaque grossesse, idéalement entre 20 et 36 SA, pour que bébé naisse protégé. **Bronchiolite (VRS)** : entre 32 et 36 SA pendant la campagne (de septembre à février en métropole), ou un traitement préventif donné à bébé après la naissance. Sans danger pour bébé et pris en charge.

L'entretien prénatal précoce : un temps pour vous

Obligatoirement proposé et pris en charge à 100 %, avec une sage-femme ou un médecin, seule ou en couple, idéalement au 1er trimestre. **Ce n'est pas un examen** : on y parle de vos besoins, de vos peurs (accouchement, allaitement, retour à la maison), de votre santé mentale, de votre organisation et du soutien dont vous disposez.

Sources : ameli.fr · HAS

Déclaration, remboursements, congés : l'essentiel

La déclaration de grossesse

À faire **avant la fin du 3e mois**. Le médecin ou la sage-femme la transmet le plus souvent **en ligne** à l'Assurance Maladie et à la CAF (ou MSA) : vous n'avez rien à envoyer. Si elle est faite sur papier, envoyez les volets aux adresses indiquées. Elle ouvre vos droits : prise en charge des examens, congé maternité, prestations familiales.

Ce qui est pris en charge

Jusqu'à la fin du 5e mois	Les consultations et examens de biologie obligatoires sont pris en charge à 100 %. Les deux premières échographies sont remboursées à 70 %. Les autres soins le sont aux taux habituels.
Du 6e mois à 12 jours après la naissance	**Tous les soins**, liés ou non à la grossesse, sont pris en charge à 100 % (sur la base du tarif de la Sécurité sociale), y compris la 3e échographie.
À tout moment	Entretien prénatal précoce, séances de préparation à la naissance, examen bucco-dentaire (du 4e mois jusqu'à 12 jours après l'accouchement), vaccins recommandés.

Les dépassements d'honoraires restent à votre charge ou à celle de votre mutuelle : prévenez-la de votre grossesse (chambre particulière, forfait naissance…).

Vos droits et aides

Prime à la naissance	Versée par la CAF ou la MSA au cours du **7e mois**, sous conditions de ressources, si la grossesse a été déclarée dans les délais. Environ 1 090 € par enfant en 2026 : vérifiez le montant et les plafonds sur caf.fr.
Congé maternité	**16 semaines** pour un 1er ou 2e enfant (6 avant, 10 après la naissance) ; 26 semaines à partir du 3e enfant ; 34 pour des jumeaux ; 46 pour des triplés. Une partie du congé prénatal peut être reportée après la naissance sur avis médical.
Second parent	**Congé de naissance** (3 jours) + **congé de paternité et d'accueil** (25 jours, 32 pour des naissances multiples), dont 7 jours obligatoires juste après la naissance. Prévenir l'employeur au moins 1 mois avant.
Nouveau en 2026	Un **congé supplémentaire de naissance** d'1 ou 2 mois par parent, indemnisé (70 % du salaire net le 1er mois, 60 % le 2e), à prendre dans les 9 mois après la naissance. En vigueur depuis le 1er juillet 2026 ; vérifiez les conditions sur service-public.fr.

Important

Les montants, délais et conditions évoluent et dépendent de votre situation (salariée, indépendante, demandeuse d'emploi, étudiante, fonctionnaire). Ce guide donne des repères, pas une décision sur vos droits : vérifiez sur **ameli.fr**, **caf.fr** ou **msa.fr** et **service-public.fr**, ou auprès de votre employeur.

Sources : ameli.fr · caf.fr · service-public.fr (octobre 2026)

Quand demander de l'aide sans attendre ?

Ces signes ne veulent pas forcément dire qu'il y a une complication, mais ils doivent être **évalués rapidement**. Vous ne dérangez jamais : en cas de doute, appelez.

15
ou le 112

Appelez le 15 (ou le 112) ou allez aux urgences si :

- douleur forte dans le ventre, surtout d'un seul côté, ou douleur à l'épaule associée à une douleur du ventre ;
- saignements abondants (comme des règles ou plus), avec ou sans caillots ;
- malaise, perte de connaissance, grande pâleur ;
- maux de tête intenses avec troubles de la vue, gonflement brutal du visage et des mains (surtout en 2e moitié de grossesse) ;
- difficultés à respirer, douleur dans la poitrine.

Contactez votre sage-femme ou votre médecin dans la journée si :

- saignements légers ou pertes brunâtres (fréquents au début et souvent sans gravité, mais toujours à signaler) ;
- fièvre à 38 °C ou plus ;
- brûlures en urinant, envie d'uriner très fréquente avec douleur, douleur dans le bas du dos sur le côté ;
- vomissements qui empêchent de boire et de s'alimenter, perte de poids ;
- pertes inhabituelles, qui sentent mauvais ou qui démangent ;
- contact avec une personne atteinte de varicelle, rubéole ou d'une éruption, si vous n'êtes pas immunisée ;
- tristesse persistante, anxiété qui envahit votre quotidien, idées noires.

Mes numéros utiles

Ma sage-femme / mon médecin : .....

Ma maternité : .....

PMI de mon secteur : .....

Pharmacie de garde : 3237 · Violences : 3919 · Tabac Info Service : 39 89

FICHE PRATIQUE

Mes premières démarches

À imprimer et à cocher au fil des semaines.

- [ ] J'ai noté le 1er jour de mes dernières règles
  Date : .....
- [ ] J'ai pris rendez-vous pour la 1re consultation
  Avec : ..... le : .....
- [ ] Je prends de l'acide folique (B9)
  Jusqu'à 12 SA, ou selon la prescription
- [ ] J'ai fait la liste de mes médicaments, compléments et allergies
  Traitement régulier : j'appelle mon médecin, je ne l'arrête pas seule
- [ ] J'ai rassemblé carte Vitale, mutuelle, carnet de vaccination, résultats récents
- [ ] J'applique les précautions alimentaires
  Toxoplasmose si non immunisée · listériose · œufs crus
- [ ] Ma déclaration de grossesse a été envoyée
  Avant la fin du 3e mois · vérifiée sur ameli.fr le : .....
- [ ] J'ai pris rendez-vous pour la 1re échographie
  Entre 11 et 13 SA + 6 j · le : .....
- [ ] Je suis inscrite à la maternité
  Laquelle : .....
- [ ] J'ai signalé mes conditions de travail (nuit, charges, produits)
- [ ] J'ai prévu mon entretien prénatal précoce

Mes questions pour le premier rendez-vous

Pas besoin de tout cocher en une semaine : **une étape à la fois**. Le professionnel qui vous suit est là pour vous guider.

FICHE PRATIQUE

Au frigo : oui / non

À aimanter sur le réfrigérateur pour toute la grossesse.

OUI

- Viande et volaille **bien cuites** à cœur
- Jambon cuit préemballé
- Œufs **durs**, omelette bien cuite
- Poisson bien cuit, 2 fois par semaine
- Poisson en conserve (sardines, maquereau)
- Comté, emmental, beaufort, gruyère sans croûte
- Fromages pasteurisés sans croûte
- Tout fromage **cuit** (gratin, pizza, raclette)
- Lait pasteurisé ou UHT, yaourts
- Fruits et légumes **bien lavés**
- Restes réchauffés jusqu'à être très chauds
- Eau à volonté

NON

- Viande crue, saignante, rosée, tartare [T]
- Jambon cru, saucisson, viande séchée [T]
- Rillettes, pâtés, foie gras, charcuterie à la coupe [L]
- Œufs crus ou mollets, mayonnaise et mousse maison [S]
- Sushis, poisson cru ou fumé, tarama, surimi [L]
- Coquillages crus [L]
- Espadon, marlin, requin, siki, lamproie [M]
- Fromages au lait cru (sauf pâtes pressées cuites) [L]
- Croûte des fromages, fromage râpé en sachet [L]
- Lait cru, graines germées crues [L]
- Alcool, sous toutes ses formes
- Boissons énergisantes

[T] toxoplasmose (si non immunisée) · [L] listériose · [S] salmonellose · [M] mercure

À limiter

Café et thé (≈ 2 tasses par jour) · thon et grands poissons (150 g par semaine) · soja (1 produit par jour) · réglisse.

En cuisine

Frigo à 4 °C, nettoyé 2 fois par mois · cru et cuit séparés · mains lavées · ustensiles lavés après la viande crue.

Un écart sans le savoir ? **Pas de panique** : le risque est faible. Signalez simplement une fièvre ou un malaise.

Sources : ANSES · Santé publique France

« C'est quoi tous ces examens ? Ils sont obligatoires ? »

CE QU'IL FAUT SAVOIR

En France, le suivi d'une grossesse comprend **7 consultations prénatales obligatoires** : une avant la fin du 3e mois, puis une par mois à partir du 4e mois. S'y ajoutent **3 échographies recommandées**, des prises de sang, l'entretien prénatal précoce et une consultation d'anesthésie. Ce calendrier peut être renforcé si votre santé ou celle de bébé le demande. Un examen supplémentaire n'est pas forcément le signe d'un problème : c'est souvent une simple vérification.

Toutes ces consultations sont l'occasion de poser vos questions. Notez-les entre deux rendez-vous.

Ce qui se passe à chaque consultation mensuelle

- Prise de la tension artérielle et du poids.
- Analyse d'urines (recherche de sucre et de protéines), avec une bandelette ou au laboratoire.
- Mesure de la hauteur du ventre (hauteur utérine) pour suivre la croissance de bébé.
- Écoute du cœur de bébé.
- Questions sur les mouvements de bébé, les contractions, les saignements, votre moral.
- Selon les mois : ordonnance pour une prise de sang ou une échographie.

Les trois échographies

ÉCHOGRAPHIE	QUAND	À QUOI ELLE SERT
1re, dite « de datation »	Entre 11 et 13 SA \+ 6 jours	Fixer la date du début de grossesse et le terme, vérifier le nombre de bébés, mesurer la clarté nucale (épaisseur de la nuque) pour le dépistage de la trisomie 21
2e, dite « morphologique »	Entre 20 et 25 SA (souvent vers 22 SA)	Examiner l'anatomie de bébé organe par organe, sa croissance, la position du placenta. Le sexe peut être connu si vous le souhaitez
3e	Entre 30 et 35 SA (souvent vers 32 SA)	Vérifier la croissance, la position de bébé (tête en bas ou en siège), la quantité de liquide et le placenta

L'échographie dure 20 à 45 minutes. Si bébé est mal placé, on peut vous demander de marcher un peu et de revenir. Vous pouvez être accompagnée.

Les prises de sang

- **Au début** : groupe sanguin et rhésus (deux déterminations), recherche d'agglutinines irrégulières (RAI), toxoplasmose, rubéole, syphilis, hépatite B. Le dépistage du VIH et de l'hépatite C est systématiquement proposé. Glycémie à jeun si vous avez des facteurs de risque de diabète.
- **Chaque mois si vous n'êtes pas immunisée contre la toxoplasmose** : une sérologie pour vérifier que vous ne l'avez pas attrapée.
- **Au 6e mois** : numération formule sanguine (recherche d'anémie), RAI selon votre groupe, hépatite B si nécessaire.
- **En fin de grossesse** : RAI selon votre groupe sanguin.

Si vous êtes de rhésus négatif

Un test sur votre prise de sang (génotypage RhD fœtal) peut indiquer le rhésus de bébé dès le 1er trimestre. Si bébé est rhésus positif, une injection préventive (immunoglobulines anti-D) vous est proposée vers 28 SA, puis après la naissance, et en cas de saignement, de chute ou de choc sur le ventre. Elle évite que votre corps fabrique des anticorps contre les globules rouges d'un bébé suivant. **À vérifier : calendrier actuel HAS/CNGOF**

Le dépistage de la trisomie 21

Il est **proposé à toutes les femmes, jamais imposé**. C'est votre choix de le faire ou non, et vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir.

1. **Dépistage combiné** au 1er trimestre : la mesure de la nuque à l'échographie, une prise de sang (marqueurs sériques) et votre âge donnent un niveau de risque.
2. Si le risque est intermédiaire ou élevé, on peut vous proposer un **test ADN** sur prise de sang (DPNI), sans risque pour la grossesse, très fiable mais qui reste un dépistage.
3. Seul un **prélèvement** (amniocentèse ou choriocentèse) permet de poser un diagnostic. Il comporte un petit risque de fausse couche et se discute avec l'équipe.

Un risque « élevé » ne veut pas dire que bébé est atteint. Un risque « faible » ne donne pas une certitude absolue. Demandez qu'on vous explique chaque étape.

Les autres rendez-vous

- **L'entretien prénatal précoce** : obligatoirement proposé, pris en charge à 100 %, avec une sage-femme ou un médecin, seule ou en couple, idéalement au 1er trimestre. Ce n'est pas un examen : c'est un temps pour parler de vos besoins, de vos peurs et de votre organisation.
- **Le dépistage du diabète gestationnel** : entre 24 et 28 SA si vous avez des facteurs de risque (voir chapitre 1.7).
- **L'examen bucco-dentaire** : pris en charge à 100 % à partir du 4e mois. Les gencives sont plus fragiles pendant la grossesse : c'est le bon moment.
- **La consultation d'anesthésie** : au 8e mois, obligatoire même si vous ne prévoyez pas de péridurale, car une anesthésie peut être nécessaire en urgence.
- **Le prélèvement vaginal** : entre 34 et 38 SA, pour rechercher le streptocoque B. S'il est présent (environ une femme sur dix, sans symptôme), un antibiotique vous sera donné pendant l'accouchement pour protéger bébé.

- **Après le terme** : si bébé n'est pas né à 41 SA, une surveillance rapprochée est mise en place à la maternité (monitoring, échographie), et un déclenchement peut être proposé.

Les vaccins recommandés pendant la grossesse

VACCIN	QUAND	POURQUOI
Grippe	Pendant la saison, à n'importe quel trimestre	La grossesse augmente le risque de grippe grave
Covid-19	Selon les recommandations de la saison	Même raison
Coqueluche	À chaque grossesse, idéalement entre 20 et 36 SA	Vos anticorps passent à bébé et le protègent dès la naissance
Bronchiolite (VRS)	Entre 32 et 36 SA pendant la campagne (septembre à février en métropole)	Protéger bébé pendant ses premiers mois ; l'autre option est un traitement préventif donné à bébé après la naissance

Ces vaccins sont sans danger pour bébé et pris en charge.

CONCRÈTEMENT

- Gardez tous vos résultats et comptes rendus dans un même dossier, à emporter à chaque rendez-vous et à la maternité.
- Notez dans votre agenda les dates limites : écho du 1er trimestre, déclaration, écho morphologique, dépistage du diabète.
- Demandez l'explication de chaque résultat que vous ne comprenez pas.

Quand consulter

Entre deux rendez-vous, n'attendez pas la consultation suivante en cas de saignements, de contractions régulières avant 37 SA, de perte de liquide, de fièvre ou si bébé bouge moins (à partir du moment où vous le sentez bouger régulièrement).

Fiche pratique : « Mon calendrier de grossesse » (date prévue / date faite / notes, pour chaque examen).

« Quand est-ce que je vais le sentir bouger ? »

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Bébé bouge très tôt, dès 7 à 8 SA, mais il est alors si petit que vous ne pouvez pas le sentir. Pour une première grossesse, on perçoit généralement les premiers mouvements **entre 18 et 22 SA** (vers le 5e mois) ; pour une grossesse suivante, souvent un peu plus tôt, vers 16 à 18 SA. Au début, cela ressemble à des bulles, des papillons ou un petit poisson. Puis les mouvements deviennent nets : coups de pied, retournements, hoquet (petits sursauts réguliers).

Si votre placenta est situé sur le devant de l'utérus (placenta antérieur), il amortit les mouvements : vous les sentirez parfois un peu plus tard. C'est sans gravité.

Bébé grandit mois par mois

Mesures moyennes, de la tête aux pieds : chaque bébé grandit à son rythme.

MOIS	TAILLE ET POIDS ENVIRON	CE QUI SE PASSE
1er mois	Quelques millimètres	Le cœur commence à battre vers 5 à 6 SA ; le tube neural (futur cerveau et moelle épinière) se forme
2e mois	3 cm, quelques grammes	Tous les organes s'ébauchent ; les bras et les jambes apparaissent ; il bouge déjà
3e mois	12 cm, 65 g	Il a une forme humaine, ses doigts sont séparés ; il commence à avaler du liquide amniotique
4e mois	20 cm, 250 g	Ses organes génitaux sont visibles à l'échographie ; il suce son pouce
5e mois	30 cm, 650 g	Vous le sentez bouger ; il entend les bruits de votre corps
6e mois	37 cm, 1 kg	Il réagit aux sons extérieurs et à votre voix ; ses poumons se préparent
7e mois	42 cm, 1,7 kg	Il ouvre les yeux ; il a des rythmes de sommeil et d'éveil
8e mois	47 cm, 2,5 kg	Il prend surtout du poids ; il se place souvent tête en bas
9e mois	50 cm, 3,3 kg	Il est prêt ; il a moins de place, ses mouvements changent (plus de poussées, moins de coups)

À vérifier : tableau de croissance selon une source de référence française

Ses sens dans le ventre

- **Le toucher** est le premier sens à se développer : il touche son visage, le cordon, la paroi de l'utérus.
- **Le goût et l'odorat** : le liquide amniotique a le goût de ce que vous mangez. Une alimentation variée l'habitue déjà à des saveurs.
- **L'ouïe** : à partir du 5e-6e mois, il entend votre cœur, votre digestion, votre voix et celle de ses proches. À la naissance, il reconnaît votre voix.
- **La vue** : il perçoit la lumière à travers la paroi du ventre en fin de grossesse.

Le lien prénatal

Le lien ne commence pas forcément à la naissance. Parler à bébé, poser les mains sur le ventre, chanter, lui faire écouter la voix de l'autre parent : ces moments simples créent une familiarité. L'haptonomie et le chant prénatal sont des approches possibles, sans obligation. Et si vous ne ressentez pas encore de lien, c'est fréquent : il se construit aussi après la naissance.

CONCRÈTEMENT

- À partir du moment où vous sentez bébé bouger tous les jours, prenez l'habitude de remarquer ses moments d'activité (souvent le soir, au repos, après un repas).
- Il n'y a pas de nombre de mouvements « normal » qui vaille pour tous les bébés. Ce qui compte, c'est **un changement** par rapport à ses habitudes.

Quand consulter

Si bébé bouge **nettement moins que d'habitude** ou ne bouge plus, n'attendez pas le lendemain : allongez-vous sur le côté gauche une demi-heure, au calme ; si vous ne sentez toujours pas de mouvements nets, **appelez ou allez à la maternité le jour même**, même la nuit. Ce n'est jamais un dérangement : un simple monitoring permet souvent de vous rassurer.

« Mon corps change, est-ce normal ? »

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Pendant neuf mois, votre corps change pour porter bébé : les hormones assouplissent les ligaments, ralentissent la digestion, augmentent le volume de sang ; le ventre grossit et déplace votre centre de gravité. La plupart des inconforts sont fréquents et sans gravité. Ils ne sont pas pour autant « à supporter » : beaucoup se soulagent (voir chapitre 1.5).

1er trimestre (jusqu'à 14 SA environ) : un bouleversement invisible

- **Fatigue intense** : elle est due aux hormones (progestérone) et s'atténue souvent au 2e trimestre. Écoutez-la : sieste, coucher plus tôt.
- **Nausées et vomissements** : chez plus d'une femme sur deux, souvent le matin, parfois toute la journée ; ils s'améliorent le plus souvent vers 12 à 16 SA.
- **Seins tendus et gonflés**, envies fréquentes d'uriner, sensibilité aux odeurs, humeur changeante.
- **Petits tiraillements** dans le bas-ventre (l'utérus grandit).

2e trimestre (15 à 28 SA) : souvent le plus agréable

- L'énergie revient, les nausées disparaissent dans la plupart des cas.
- Le ventre s'arrondit ; les premiers mouvements de bébé apparaissent.
- Apparaissent parfois : **ligne brune** sur le ventre, **masque de grossesse** (taches sur le visage, à protéger du soleil), **vergetures**, gencives qui saignent, nez bouché, crampes dans les mollets.
- Douleurs **ligamentaires** sur les côtés du ventre lors des mouvements brusques.

3e trimestre (29 SA à la naissance) : le corps se prépare

- **Mal de dos**, douleurs du bassin (pubis, fesses, sacrum), sensation de lourdeur.
- **Reflux et brûlures d'estomac**, essoufflement (l'utérus remonte sous les côtes).
- **Jambes lourdes**, chevilles qui gonflent le soir, varices, hémorroïdes, constipation.
- **Fourmillements dans les mains** la nuit (syndrome du canal carpien), fréquent et réversible après la naissance.
- **Sommeil difficile** : ventre encombrant, envies d'uriner, crampes, rêves intenses.
- **Contractions indolores** (le ventre durcit quelques secondes) : normales si elles sont rares et irrégulières.

La prise de poids

Elle dépend de votre poids avant la grossesse (IMC). Repères : 11,5 à 16 kg pour un IMC entre 18,5 et 25 ; 12,5 à 18 kg en dessous ; 7 à 11,5 kg entre 25 et 30 ; 5 à 9 kg au-delà de 30. Pas de régime pendant la grossesse ; le professionnel suit votre courbe. **À vérifier : repères IOM utilisés en France**

Le périnée pendant la grossesse

Le périnée est l'ensemble des muscles qui ferment le bas du bassin et soutiennent la vessie, l'utérus et le rectum. Pendant la grossesse, il porte un poids croissant et s'assouplit sous l'effet des hormones. Des **petites fuites urinaires** à l'effort (toux, éternuement, rire) sont fréquentes, surtout en fin de grossesse. Ce n'est pas une fatalité : parlez-en, des exercices existent.

L'ESPACE DU KINÉ

Bouger pendant la grossesse, oui, et c'est bénéfique. Sauf contre-indication, l'activité physique réduit le mal de dos, la fatigue, le risque de diabète gestationnel et prépare le corps à l'accouchement. Repère : **150 minutes par semaine** d'activité modérée (vous pouvez parler en bougeant). Marche, natation, aquagym, vélo d'appartement, yoga ou Pilates prénatal. À éviter : sports de contact, sports à risque de chute, plongée sous-marine.

Pour votre dos au quotidien :

- Pour ramasser un objet, pliez les genoux plutôt que le dos, et gardez la charge près du corps.
- Pour sortir du lit, tournez-vous sur le côté, puis poussez avec les bras pour vous asseoir.
- Évitez de rester longtemps debout immobile ; alternez les positions.
- Avant de soulever ou de tousser : expirez en contractant le périnée (« je retiens une envie d'uriner »).

Quand consulter

- Douleur forte et brutale dans le ventre, ventre dur en permanence.
- Contractions régulières et douloureuses avant 37 SA.
- Saignements, perte de liquide.
- Maux de tête intenses, troubles de la vue, gonflement brutal du visage et des mains, douleur en haut du ventre (signes de pré-éclampsie, surtout en 2e moitié de grossesse).
- Démangeaisons intenses des paumes et des plantes de pieds, surtout la nuit, en fin de grossesse (signe possible de cholestase gravidique).
- Mollet rouge, chaud, douloureux, gonflé d'un seul côté.
- Douleur en urinant, fièvre.

« Qu'est-ce qui peut me soulager ? »

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Les inconforts de la grossesse ne se soignent pas tous avec des médicaments, et c'est tant mieux : la plupart se soulagent avec des positions, du mouvement, quelques accessoires bien choisis et, si besoin, un professionnel. Le kinésithérapeute et la sage-femme peuvent prendre en charge le mal de dos et les douleurs du bassin pendant la grossesse, sur prescription. **À vérifier : modalités de prise en charge**

Petit guide des soulagements

INCONFORT	CE QUI AIDE
Nausées	Petits repas fréquents, quelque chose de sec avant de se lever, boire entre les repas, gingembre ; si vous ne gardez rien : consulter
Mal de dos (bas du dos)	Bouger, marcher, bascule du bassin, chaleur, ceinture de soutien si la douleur est liée à l'effort, kiné
Douleurs du bassin (pubis, fesses)	Garder les genoux serrés pour sortir de la voiture ou du lit, éviter de se tenir sur une jambe (s'habiller assise), ceinture de soutien pelvien, kiné
Jambes lourdes, gonflement	Surélever les jambes, marcher, eau fraîche sur les jambes, bas de contention (remboursés sur prescription)
Crampes	Étirer le mollet (tirer la pointe du pied vers soi), boire, bouger dans la journée
Reflux	Repas fractionnés, éviter de s'allonger après manger, surélever la tête du lit, traitement adapté sur avis
Constipation, hémorroïdes	Boire, fibres, marcher, ne pas pousser, surélever les pieds sur un petit tabouret aux toilettes
Fourmillements des mains	Attelle de repos la nuit (poignet droit), ne pas dormir les poignets pliés
Sommeil	Dormir sur le côté avec un coussin entre les genoux à partir du 3e trimestre, rituel calme, limiter les écrans le soir

Les accessoires : utiles ou gadgets ?

- **Coussin de grossesse (ou d'allaitement)** : utile pour dormir sur le côté, soutenir le ventre et les genoux. Il resservira pour l'allaitement. Un oreiller classique entre les genoux peut suffire.
- **Ceinture de soutien lombaire ou pelvienne** : utile en cas de douleurs du bassin ou du dos à la marche, à porter pendant les activités, pas toute la journée (les muscles doivent continuer à travailler). Demandez conseil pour la taille et le modèle.
- **Bandes adhésives (straps, taping)** : posées par un kiné ou une sage-femme formés, elles peuvent soulager certaines douleurs du dos ou du ventre. L'effet varie selon les personnes.
- **Ballon de grossesse** : intéressant pour s'asseoir en mobilisant le bassin, faire des exercices doux, et pendant le travail.
- **Bas de contention** : très efficaces pour les jambes lourdes et en voyage, sur prescription.
- **Moins utiles** : crèmes « anti-vergetures » miracle (l'hydratation est agréable, mais aucune crème ne prévient de façon prouvée les vergetures), compléments « spécial grossesse » sans avis.

L'ESPACE DU KINÉ

Trois exercices simples à faire chaque jour, s'ils ne sont pas douloureux.

1. **La bascule du bassin** : à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. En expirant, enroulez le bas du dos vers le plafond (dos rond, comme un chat) ; en inspirant, revenez au dos plat, sans creuser. 10 fois, lentement.
2. **L'étirement sur le côté** : assise en tailleur ou sur le ballon, levez un bras au-dessus de la tête et penchez-vous doucement du côté opposé. 3 respirations de chaque côté. Il redonne de l'espace sous les côtes.
3. **La respiration avec le périnée** : assise, inspirez en gonflant le ventre et en relâchant le périnée ; expirez en rentrant doucement le nombril et en contractant le périnée. 10 respirations. Elle prépare aussi à la récupération après la naissance.

Arrêtez un exercice qui provoque une douleur, des contractions ou des saignements.

Quand consulter

Une douleur qui vous empêche de marcher, de dormir ou qui s'aggrave malgré le repos ; une douleur du dos avec fièvre ou brûlures urinaires ; une douleur du bas-ventre qui revient de façon régulière (contractions).

« Qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'évite ? »

CE QU'IL FAUT SAVOIR

On ne mange pas pour deux, on mange deux fois mieux. Au 1er trimestre, les besoins en énergie n'augmentent presque pas ; aux 2e et 3e trimestres, l'équivalent d'une collation en plus suffit. Ce qui compte, c'est la variété et quelques précautions contre trois infections transmises par l'alimentation.

NOTE DE RELECTURE

Le contenu détaillé est déjà rédigé dans le chapitre 1.1 (quatre pages). Il pourra être déplacé ici et allégé dans le 1.1 : à décider à la relecture.

Les points clés

- **Chaque jour** : fruits et légumes à chaque repas (bien lavés), féculents de préférence complets, protéines 1 à 2 fois (viande et œufs bien cuits, poisson 2 fois par semaine, légumineuses), 2 à 3 produits laitiers, de l'eau à volonté.
- **Compléments** : acide folique jusqu'à 12 SA, vitamine D au 7e mois, fer seulement si manque, sel iodé, vitamine B12 si vous êtes végétalienne.
- **Toxoplasmose** (si vous n'êtes pas immunisée) : viande bien cuite, pas de charcuterie crue, fruits et légumes bien lavés, gants pour le jardin et la litière.
- **Listériose** (pour toutes) : pas de fromages au lait cru (sauf comté, emmental, beaufort, gruyère), pas de croûte, pas de charcuterie à la coupe, rillettes, pâtés, poisson cru ou fumé, coquillages crus, graines germées crues.
- **Salmonellose** : œufs bien cuits ; pas de mayonnaise, mousse ou tiramisu faits maison.
- **Poissons** : éviter espadon, marlin, siki, requin, lamproie ; limiter le thon et les grands poissons à 150 g par semaine.
- **Caféine** : 200 mg par jour au maximum, soit environ 2 cafés ; éviter les boissons énergisantes.
- **Alcool** : zéro, dès maintenant. Si vous avez bu avant de savoir : pas de panique, parlez-en.
- **Tabac** : de l'aide existe, sans jugement : substituts nicotiniques remboursés, Tabac Info Service 39 89.
- **Médicaments** : rien sans avis ; paracétamol en cas de douleur ou de fièvre ; jamais d'ibuprofène ni d'anti-inflammatoire à partir du 6e mois.

Quand consulter

Fièvre à 38 °C ou plus, même avec de simples courbatures ; vomissements qui empêchent de boire ; perte de poids.

Fiche pratique : « Au frigo : oui / non ».

« Mon test de diabète est positif »

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Le diabète gestationnel est un excès de sucre dans le sang qui apparaît pendant la grossesse : les hormones du placenta rendent l'insuline moins efficace. Il concerne environ **une grossesse sur dix** en France. Il ne donne en général aucun symptôme, d'où le dépistage. Il disparaît le plus souvent après l'accouchement.

Ce n'est pas de votre faute, et ce n'est pas une maladie « grave » quand il est pris en charge. Bien suivi, il n'a le plus souvent pas de conséquence pour bébé. Non suivi, il peut entraîner un bébé plus gros que la moyenne, un accouchement plus difficile, une hypoglycémie de bébé à la naissance et une hypertension chez la mère.

Qui est dépistée et comment ?

Le dépistage est proposé si vous avez au moins un facteur de risque : 35 ans ou plus ; surpoids avant la grossesse (IMC de 25 ou plus) ; diabète de type 2 chez un parent, un frère ou une sœur ; diabète gestationnel ou bébé de plus de 4 kg lors d'une grossesse précédente.

- Au 1er trimestre : **glycémie à jeun**. Elle est anormale à partir de 0,92 g/L.
- Entre 24 et 28 SA : **hyperglycémie provoquée** (HGPO). On mesure le sucre à jeun, puis vous buvez une boisson très sucrée (75 g de glucose) et on mesure à 1 heure et à 2 heures. Il suffit d'une valeur au-dessus du seuil (0,92 g/L à jeun ; 1,80 g/L à 1 h ; 1,53 g/L à 2 h) pour poser le diagnostic.
  À vérifier : seuils CNGOF/SFD en vigueur

Ce qui va se mettre en place

1. **Un rendez-vous avec une diététicienne ou un diabétologue**, souvent dans la semaine qui suit.
2. **L'autosurveillance** : vous mesurez votre sucre au bout du doigt avec un petit lecteur, en général 4 à 6 fois par jour (à jeun le matin et après les repas). Le matériel est pris en charge. Objectifs habituels : moins de 0,95 g/L à jeun et moins de 1,20 g/L deux heures après le début du repas. À vérifier
3. **L'alimentation adaptée** (ci-dessous) et l'**activité physique**.
4. **Si cela ne suffit pas** après une à deux semaines : de l'**insuline** en injections, sans danger pour bébé. Elle ne passe pas le placenta. Ce n'est pas un échec : c'est un outil.
5. **Une surveillance de bébé** un peu plus rapprochée (échographies de croissance).

L'alimentation : pas un régime, une nouvelle organisation

- **3 repas et 2 à 3 collations**, à heures régulières : on étale les glucides sur la journée plutôt que de les supprimer.
- **Des féculents à chaque repas**, en quantité modérée, de préférence complets ou associés à des légumes : pain complet, légumineuses, riz, pâtes al dente.
- **Des légumes à volonté**, à chaque repas : leurs fibres ralentissent le passage du sucre dans le sang.
- **Des protéines** à chaque repas (viande, poisson, œufs, produits laitiers, légumineuses).
- **Les fruits** : 2 à 3 par jour, en entier plutôt qu'en jus, de préférence à la fin d'un repas ou en collation avec un laitage.
- **À limiter fortement** : boissons sucrées et jus de fruits, sucreries, pâtisseries, céréales du petit-déjeuner sucrées.
- **Ne pas sauter de repas** et ne pas réduire fortement les quantités : bébé a besoin d'énergie, et un régime trop strict peut être contre-productif.

Exemple de journée

- Petit-déjeuner : pain complet, beurre ou fromage, un yaourt nature, un thé ou un café.
- Collation : une pomme et une poignée d'amandes.
- Déjeuner : crudités, poisson ou viande, lentilles ou riz complet (une portion modérée), légumes, un laitage.
- Collation : un fromage blanc et quelques fruits rouges.
- Dîner : soupe de légumes, omelette, une petite portion de pâtes, légumes, un fruit.
- Collation du soir si besoin : un verre de lait ou un yaourt.

L'ESPACE DU KINÉ

Le mouvement fait baisser le sucre dans le sang : les muscles l'utilisent comme carburant. **15 minutes de marche après chaque repas** sont l'un des moyens les plus efficaces et les plus simples. Visez au total 30 minutes d'activité par jour, 5 jours sur 7 : marche, vélo d'appartement, natation, gym douce.

Et après la naissance ?

- La surveillance du sucre s'arrête en général après l'accouchement (avec un contrôle chez bébé à la naissance).
- Le diabète gestationnel augmente le risque de diabète de type 2 plus tard, et d'un nouveau diabète gestationnel lors d'une grossesse suivante. Un **contrôle de la glycémie** est recommandé lors de la consultation postnatale, puis régulièrement (tous les 1 à 3 ans). À vérifier
- L'allaitement, une activité physique régulière et une alimentation équilibrée réduisent ce risque.

Quand consulter

Des glycémies souvent au-dessus des objectifs ; des malaises (sueurs, tremblements) si vous êtes sous insuline ; une soif ou des envies d'uriner très importantes.

Fiche pratique : « Mon carnet de glycémies » (tableau sur 7 jours : à jeun, après chaque repas, ce que j'ai mangé, activité).

« Je pleure tout le temps, j'ai très faim : c'est normal ? »

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Oui. Les hormones de la grossesse (progestérone, œstrogènes) agissent aussi sur le cerveau : émotions plus intenses, larmes faciles, irritabilité, besoin de sommeil, fringales ou au contraire dégoût de certains aliments. Ajoutez à cela la fatigue, les nausées, les questions sur l'avenir, et il est normal de passer du rire aux larmes. **Ressentir des émotions contradictoires** (joie et peur, envie et regret, impatience et inquiétude) ne fait pas de vous une mauvaise future mère.

La faim

- Au 1er trimestre, manger souvent calme parfois les nausées.
- Les besoins augmentent vraiment aux 2e et 3e trimestres : une collation en plus est normale.
- Préférez des collations qui tiennent au corps : un fruit et un laitage, du pain complet avec du fromage, une poignée d'oléagineux.
- Les envies particulières sont fréquentes ; elles n'ont rien de dangereux tant qu'il ne s'agit pas d'aliments à risque. L'envie de manger des choses non alimentaires (terre, glace, craie) se signale : elle peut être liée à un manque de fer.

Les peurs fréquentes

- **La peur que quelque chose arrive à bébé**, surtout au 1er trimestre ou après une perte précédente.
- **La peur de l'accouchement** : de la douleur, de perdre le contrôle, d'une césarienne. En parler, se renseigner (module 2) et préparer la naissance aide beaucoup.
- **La peur de ne pas être un bon parent** (« est-ce qu'on va être de bons parents ? ») : se poser la question est déjà un signe d'attention. Il n'existe pas de parent parfait ; un parent « suffisamment bon » répond aux besoins de son enfant la plupart du temps, se trompe parfois et répare.
- **Les changements dans le couple**, le corps, le travail, la liberté.

Ce qui aide

- En parler : au partenaire, à une amie, à la sage-femme. L'**entretien prénatal précoce** est fait pour cela.
- Dormir, même en journée ; réduire ce qui n'est pas indispensable.
- Bouger un peu chaque jour : la marche apaise.
- Limiter les forums et les récits d'accouchement inquiétants ; choisir ses sources.
- La préparation à la naissance (sophrologie, yoga, haptonomie) aide aussi à apprivoiser les émotions.

Quand demander de l'aide

La tristesse ou l'anxiété deviennent préoccupantes quand elles durent **plus de deux semaines**, occupent la plupart de vos journées, vous empêchent de dormir, de manger ou de fonctionner, ou s'accompagnent d'une perte de plaisir pour tout. Environ une femme sur dix traverse une dépression pendant la grossesse : cela se soigne. Parlez-en à votre sage-femme ou à votre médecin, qui peut vous orienter vers un psychologue (des séances peuvent être prises en charge) ou un psychiatre périnatal.

Si vous avez des idées noires ou pensez à vous faire du mal : appelez le **3114** (numéro national de prévention du suicide, gratuit, 24 h/24) ou le **15**.

Fiche pratique : « Mon baromètre émotionnel » (une ligne par semaine : comment je me sens, ce qui m'a fait du bien, ce que je veux dire à la sage-femme).

VOUS, LES PARENTS

MODULE 1 · CHAPITRE 1.9 · LA GROSSESSE

« Et moi, le futur papa ou coparent, comment l'aider ? »

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Vous ne portez pas le bébé, mais vous devenez parent vous aussi, dès maintenant. Il est fréquent de se sentir un peu « à côté » : le corps de votre partenaire change, les rendez-vous la concernent d'abord, et le bébé semble abstrait jusqu'aux premiers mouvements ou à la première échographie. Votre place se construit en agissant.

Comprendre ce qu'elle vit

Fatigue écrasante, nausées, émotions intenses, inquiétudes, douleurs : ce n'est ni de la comédie ni de la mauvaise humeur, c'est la grossesse. La meilleure aide commence souvent par **l'écoute** : demander « comment tu te sens aujourd'hui ? » et accueillir la réponse sans chercher à tout résoudre ni minimiser (« ça va passer »).

Soulager au quotidien

- **Prendre des sujets entièrement en charge** plutôt que « proposer de l'aide » : courses, repas, linge, ménage, papiers, rendez-vous. Penser, organiser et faire, pas seulement exécuter.
- Cuisiner en tenant compte des nausées (odeurs) et des précautions alimentaires.
- Changer la litière du chat, porter les charges lourdes.
- Préserver son sommeil : la laisser dormir, prendre le relais le week-end.
- Arrêter de fumer, ou au moins ne jamais fumer à l'intérieur ni en voiture : c'est aussi le moment de se faire aider (substituts remboursés).

Être présent aux étapes clés

- **Les rendez-vous** : le second parent salarié a droit à une **autorisation d'absence pour 3 examens prénataux** obligatoires, sans perte de salaire. Les échographies sont souvent des moments forts.
- **L'entretien prénatal précoce** et les **séances de préparation à la naissance** : vous y êtes le bienvenu. Vous y apprendrez votre rôle pendant l'accouchement (massages, respiration, soutien, porte-parole auprès de l'équipe).
- **Le projet de naissance**, les achats, le choix du mode de garde : décider à deux.
- **Les démarches** : reconnaissance anticipée si vous n'êtes pas mariés, congés à anticiper avec votre employeur (congé de paternité et d'accueil, congé supplémentaire de naissance).

Créer le lien avec bébé

Parlez-lui, posez vos mains sur le ventre quand il bouge, lisez-lui une histoire le soir : à la naissance, il reconnaîtra votre voix. Après la naissance, le peau à peau, le bain, le change et le portage seront vos moments à vous.

Et vous, comment allez-vous ?

Vous avez le droit d'avoir peur, de vous sentir dépassé, d'être inquiet pour l'argent ou le travail. Certains hommes ressentent même des symptômes physiques (prise de poids, troubles digestifs). Jusqu'à **1 père sur 10** traverse une dépression autour de la naissance : irritabilité, fuite dans le travail, l'alcool ou les écrans, sentiment d'inutilité. Parlez-en à votre médecin, et à votre partenaire.

Fiche pratique : « Qui fait quoi pendant la grossesse » (tableau de répartition à remplir ensemble).

« De quoi ai-je réellement besoin pour accueillir bébé ? »

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Un nouveau-né a besoin de très peu de choses : dormir en sécurité, manger, être changé, être porté et voyager en sécurité. Le reste peut attendre ou s'emprunter. Commencez les achats vers le 6e ou 7e mois, avec une liste : vous éviterez les dépenses inutiles et pourrez demander à l'entourage ce qui vous manque.

Les indispensables

BESOIN	L'ESSENTIEL	À SAVOIR
Dormir	Un lit à barreaux ou un berceau conforme aux normes, un matelas ferme parfaitement ajusté, 2 draps-housses, 2 gigoteuses (turbulettes)	Rien d'autre dans le lit : pas d'oreiller, de couette, de tour de lit, de cale-bébé ni de peluche
Voyager	Un siège auto homologué (norme R129, dite i-Size), installé **dos à la route**	Indispensable dès la sortie de la maternité ; neuf ou d'occasion récente avec historique connu (jamais accidenté)
Se promener	Poussette avec nacelle ou siège allongeable, ou porte-bébé physiologique	La nacelle ou le portage sont adaptés aux premiers mois
Être changé	Un plan à langer à bonne hauteur, des couches, du coton, du liniment ou de l'eau et du savon doux, des serviettes	Ne jamais laisser bébé seul sur la table à langer, même une seconde
Le bain	Une petite baignoire ou une bassine, un thermomètre de bain (37 °C), un savon doux	Le bain n'est pas obligatoire tous les jours
Manger	Si allaitement : 2 à 3 soutiens-gorge d'allaitement, coussinets. Si biberon : 4 à 6 biberons, goupillon	Un tire-lait se loue en pharmacie sur prescription
Se soigner	Thermomètre rectal ou frontal, sérum physiologique en dosettes, compresses, ciseaux à bouts ronds	Le carnet de santé est remis à la maternité

La chambre

- Recommandé : bébé dort **dans la chambre des parents**, dans son propre lit, au moins pendant les 6 premiers mois.
- Température de la pièce : **18 à 20 °C**. Pas de tabac dans le logement.
- Le lit loin des radiateurs, des fenêtres, des cordons de rideaux et des prises.
- La table à langer près d'un point d'eau si possible, avec tout à portée de main pour ne jamais lâcher bébé.

Les vêtements

- Taille **naissance** (50 cm) : peu de pièces, bébé la dépasse souvent en quelques semaines ; **1 mois** et **3 mois** : l'essentiel.
- Pour démarrer : 6 à 8 bodys, 6 à 8 pyjamas, 2 à 3 gilets, 1 bonnet (pour les premiers jours et les sorties par temps frais), des chaussettes, une tenue adaptée à la saison pour sortir.
- Laver les vêtements neufs avant de les utiliser, avec une lessive douce.
- Règle simple : bébé porte une couche de vêtements de plus que vous.

Les achats facultatifs ou peu utiles

Chauffe-biberon, stérilisateur (un lavage soigneux suffit dans la plupart des cas), babyphone (utile surtout si la maison est grande), transat (pratique mais à utiliser peu de temps), mouche-bébé électrique, matelas à langer chauffant, tour de lit (**déconseillé**), cale-bébé (**déconseillé**), coussin anti-tête plate (**déconseillé**), trotteur (**déconseillé**).

La valise de maternité (à préparer vers 7 mois)

Pour vous : chemises de nuit ou grands t-shirts, culottes jetables ou en coton, serviettes hygiéniques maternité, soutiens-gorge d'allaitement, affaires de toilette, chaussons, tenue confortable pour la sortie, eau et collations, chargeur de téléphone, dossier de grossesse (résultats, échographies, carte Vitale, carte de mutuelle, pièce d'identité, livret de famille ou reconnaissance anticipée).

Pour bébé : 6 bodys, 6 pyjamas, 2 gilets, un bonnet, des chaussettes, 2 gigoteuses, une tenue de sortie, une couverture pour le siège auto. Renseignez-vous auprès de la maternité : certaines fournissent les couches et le linge.

Fiches pratiques : « Checklist des achats » (indispensable / pratique / peut attendre), « Ma valise de maternité ».

« Comment préparer l'accouchement et le retour à la maison ? »

CE QU'IL FAUT SAVOIR

On ne peut pas tout prévoir pour un accouchement, mais se préparer réduit l'anxiété et aide à mieux vivre ce moment, quel qu'il soit. La préparation concerne aussi les premières semaines à la maison, souvent plus fatigantes qu'on ne l'imagine.

La préparation à la naissance et à la parentalité

- **7 séances** sont prises en charge à 100 %, en plus de l'entretien prénatal précoce. Elles commencent en général vers le 6e ou 7e mois, avec une sage-femme (ou un médecin), en groupe ou individuellement.
  À vérifier : nombre de séances et modalités
- On y parle du déroulement de l'accouchement, des positions, de la respiration, de la gestion de la douleur, de l'allaitement, des soins à bébé et du retour à la maison.
- Plusieurs approches existent : classique, sophrologie, yoga prénatal, préparation en piscine, haptonomie (centrée sur le lien et le toucher, avec le partenaire), chant prénatal. Choisissez ce qui vous ressemble.
- Le partenaire est le bienvenu, au moins à certaines séances.
- Visitez la maternité si c'est proposé.

Le projet de naissance

C'est un document court (une page) où vous exprimez vos souhaits : accompagnant, gestion de la douleur, positions, ambiance, peau à peau, premier repas de bébé, présence pendant une éventuelle césarienne… Il se discute avec la sage-femme ou à la maternité, vers le 8e mois, et s'ajoute à votre dossier.

Gardez en tête que c'est un projet, pas un contrat : l'équipe le respectera autant que possible, mais adaptera si la situation l'exige. Formulez-le avec souplesse (« si possible, j'aimerais… »).

Recueillir son colostrum avant la naissance (si vous le souhaitez)

Le colostrum est le premier lait, épais et jaune, très riche. Certaines femmes choisissent d'en recueillir quelques gouttes en fin de grossesse pour les donner à bébé après la naissance si besoin (diabète gestationnel, bébé à risque d'hypoglycémie, souhait de préparer l'allaitement).

- C'est une démarche **à discuter d'abord avec votre sage-femme ou votre médecin**, qui vous dira si c'est adapté à votre situation. On l'évite en général en cas de risque d'accouchement prématuré ou de contractions.
- On commence habituellement **vers 36-37 SA**, par expression manuelle douce, quelques minutes, une à deux fois par jour.
- On recueille les gouttes dans une petite seringue stérile, étiquetée (date, heure), conservée au réfrigérateur ou au congélateur selon les consignes, puis transportée à la maternité au froid.
- Si des contractions apparaissent pendant le recueil, on arrête.

À vérifier : protocole et conseils de conservation à valider par une sage-femme ou une consultante en lactation

Préparer l'après

- **Les repas** : cuisinez et congelez des plats en portions dans les dernières semaines ; listez les repas faciles ; acceptez les plats offerts.
- **La maison** : linge à jour, courses de base (couches, produits d'hygiène, denrées non périssables), siège auto déjà installé dans la voiture.
- **Les relais** : qui peut aider les premières semaines ? (courses, aînés, animaux, ménage). Notez les noms et les numéros.
- **Les personnes à prévenir** le jour J : maternité, accompagnant, garde des aînés et des animaux, employeur.
- **Le trajet** : repérez la route et le temps de trajet, l'entrée de nuit de la maternité, le stationnement.
- **Le retour** : la sage-femme à domicile (programme de retour à domicile de l'Assurance Maladie) peut être organisée dès la maternité ; repérez une sage-femme libérale près de chez vous.

Quand partir à la maternité

Voir chapitre 2.1. En résumé : contractions régulières et douloureuses (toutes les 5 minutes depuis 1 à 2 heures pour un premier bébé), perte des eaux, saignements, bébé qui bouge moins, ou tout doute.

Fiches pratiques : « Mon projet de naissance » (modèle à remplir), « Préparer mon retour à la maison ».

Quand consulter et fiches à imprimer

15
ou le 112

Appelez le 15 (ou le 112) sans attendre

- Saignements abondants.
- Douleur intense et brutale du ventre, ventre dur en permanence.
- Perte de connaissance, convulsions.
- Maux de tête violents avec troubles de la vue, gonflement brutal du visage et des mains.
- Difficultés à respirer, douleur dans la poitrine.

Allez à la maternité (ou appelez-la) le jour même

- Bébé bouge nettement moins ou ne bouge plus.
- Perte de liquide (eau claire, teintée ou verte).
- Contractions régulières et douloureuses, surtout avant 37 SA.
- Fièvre à 38 °C ou plus.
- Saignements, même légers, au 2e ou au 3e trimestre.
- Démangeaisons intenses des mains et des pieds en fin de grossesse.

Contactez votre sage-femme ou votre médecin dans la journée

- Saignements légers au 1er trimestre.
- Brûlures en urinant, pertes inhabituelles.
- Vomissements qui empêchent de boire.
- Mollet rouge, chaud, douloureux d'un seul côté.
- Contact avec une personne malade (varicelle, rubéole, éruption) si vous n'êtes pas immunisée.
- Tristesse ou anxiété qui durent plus de deux semaines.

Numéros utiles : 15 (SAMU), 112, 3114 (prévention du suicide), 3919 (violences), Tabac Info Service 39 89, pharmacie de garde 3237, votre maternité, votre sage-femme.

À IMPRIMER

Les fiches à imprimer du module 1

1. Mes premières démarches (checklist) — chapitre 1.1
2. Au frigo : oui / non — chapitres 1.1 et 1.6
3. Mon calendrier de grossesse — chapitre 1.2
4. Mon carnet de glycémies — chapitre 1.7
5. Mon baromètre émotionnel — chapitre 1.8
6. Qui fait quoi pendant la grossesse — chapitre 1.9
7. Checklist des achats — chapitre 1.10
8. Ma valise de maternité — chapitre 1.10
9. Mon projet de naissance — chapitre 1.11
10. Préparer mon retour à la maison — chapitre 1.11
11. Mes questions pour le prochain rendez-vous (page de notes) — tous les chapitres

FICHE PRATIQUE

Mon calendrier de grossesse

Notez les dates prévues, cochez quand c'est fait. À garder dans votre dossier de grossesse.

EXAMEN	QUAND	DATE PRÉVUE	FAIT LE
1re consultation, déclaration	Avant la fin du 3e mois		☐
Prises de sang du début	1er trimestre		☐
1re échographie	11 à 13 SA + 6 j		☐
Entretien prénatal précoce	1er trimestre		☐
Inscription à la maternité	1er trimestre		☐
Consultation du 4e mois	4e mois		☐
Examen bucco-dentaire	Dès le 4e mois		☐
Consultation du 5e mois	5e mois		☐
2e échographie	20 à 25 SA		☐
Dépistage du diabète (si besoin)	24 à 28 SA		☐
Consultation du 6e mois, prise de sang	6e mois		☐
Consultation du 7e mois	7e mois		☐
3e échographie	30 à 35 SA		☐
Vaccins (coqueluche, VRS, grippe)	Selon le calendrier		☐
Consultation d'anesthésie	8e mois		☐
Consultation du 8e mois	8e mois		☐
Prélèvement vaginal (strepto B)	34 à 38 SA		☐
Consultation du 9e mois	9e mois		☐

FICHE PRATIQUE

Ma valise de maternité

À préparer vers le 7e mois. Vérifiez la liste de votre maternité : certaines fournissent couches et linge.



Pour moi

- [ ] Dossier de grossesse et résultats
- [ ] Carte Vitale, mutuelle, pièce d'identité
- [ ] Livret de famille ou reconnaissance anticipée
- [ ] Chemises de nuit ou grands t-shirts
- [ ] Culottes jetables ou en coton
- [ ] Serviettes hygiéniques maternité
- [ ] Soutiens-gorge d'allaitement, coussinets
- [ ] Affaires de toilette, serviette
- [ ] Chaussons, chaussettes
- [ ] Tenue confortable pour la sortie
- [ ] Eau, collations, chargeur de téléphone

Pour bébé

- [ ] 6 bodys taille naissance et 1 mois
- [ ] 6 pyjamas
- [ ] 2 gilets
- [ ] 1 bonnet, chaussettes
- [ ] 2 gigoteuses
- [ ] Une tenue de sortie
- [ ] Une couverture pour le siège auto
- [ ] Le siège auto installé dans la voiture

Préparez aussi un petit sac pour la salle de naissance : brumisateur, élastique à cheveux, musique, collation pour l'accompagnant.

FICHE PRATIQUE

Mon projet de naissance

Une page pour exprimer vos souhaits, à discuter avec la sage-femme vers le 8e mois. C'est un projet, pas un contrat.



Qui m'accompagne

Ce que je souhaite pour gérer la douleur

Les positions, l'ambiance (lumière, musique, bain...)

Le peau à peau et le premier repas de bébé (sein, biberon)

Si une césarienne est nécessaire

Ce qui est important pour moi, ce que je redoute

FICHE PRATIQUE

Mon carnet de glycémies



En cas de diabète gestationnel : notez vos résultats et apportez ce carnet à chaque rendez-vous.

JOUR	À JEUN	APRÈS LE PETIT-DÉJ.	APRÈS LE DÉJEUNER	APRÈS LE DÎNER	REPAS, ACTIVITÉ, REMARQUES
Lundi					
Mardi					
Mercredi					
Jeudi					
Vendredi					
Samedi					
Dimanche					

Objectifs habituels : moins de 0,95 g/L à jeun et moins de 1,20 g/L deux heures après le début du repas. Suivez ceux que votre équipe vous a donnés.

SOURCES ET AVERTISSEMENT

Pour aller plus loin

Sources officielles

Assurance Maladie (ameli.fr), Haute Autorité de Santé, Santé publique France et 1000-premiers-jours.fr, ANSES, CRAT, CNGOF, Collège national des sages-femmes, Service-public.fr, CAF. Ce contenu est un support d'information et ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé.

Les calendriers, montants et droits évoluent : vérifiez toujours la version en vigueur sur ameli.fr, service-public.fr, caf.fr et has-sante.fr.

Note de prudence

Ce module est un support d'information. Il ne remplace pas une consultation, une prescription ni l'avis d'une sage-femme, d'un médecin ou d'un professionnel de santé. En cas d'urgence, appelez le **15** ou le **112**.

DANS LE PROCHAIN MODULE

Module 2 · L'accouchement

« Comment je vais savoir que c'est le moment ? »